

Panel + EKG — *wstępnie i regularnie*

AN wymaga systematycznego monitorowania labowego. Nawet pacjenci wyglądający „stabilnie” mogą mieć zagrażające życiu zaburzenia elektrolitowe.

CZAS: 10 min psychoedukacji + organizacja **REALIZACJA:** wstępnie + regularnie (zależnie od ciężkości)

ŹRÓDŁO: AED Medical Care Standards (2021); Mehler & Brown (2015); Mehler & Andersen (2017); NICE (2017)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **panel podstawowy**: morfologia, elektrolity (z fosforem i magnezem), funkcja nerek, ALT/AST, glukoza. W sekcji 02 — **panel rozszerzony**: hormony, EKG, DEXA. Sekcja 03 — **częstotliwość** zależna od ciężkości (MEED).

DLACZEGO TO DZIAŁA

AN wymaga systematycznego monitorowania laboratoryjnego — pacjenci wyglądający „stabilnie” mogą mieć zagrażające życiu zaburzenia elektrolitowe. Standardowy panel (AED, 2021; Mehler & Brown, 2015): morfologia, elektrolity (Na, K, Mg, P, Ca), funkcja wątroby i nerek, glukoza, TSH, witaminy (B12, D), EKG. **Częstotliwość**: tygodniowo w fazie refeedingu, co 1–3 mies. potem. Hipokaliemia, hipofosfatemia, wydłużone QT — wskaźniki pilnej interwencji medycznej, niezależnie od BMI.

01 Panel podstawowy — wstępnie + regularnie

BADANIE

CO OCENIAMY

Morfologia	Anemia, leukopenia, trombocytopenia — możliwa pancytopenia z głodu (osłabienie szpiku).
Elektrolity + P, Mg	Na, K, Cl, HCO ₃ , fosfor i magnez — często pomijane, kluczowe przy refeedingu i kompensacjach.
Funkcja nerek	Kreatynina, mocznik — odwodnienie, niewydolność nerek przy ciężkim niedożywieniu.
Glukoza	Możliwa hipoglikemia, szczególnie rano lub po dłuższych przerwach żywieniowych.
ALT/AST	Mogą być podwyższone w głodzie (autofagia wątroby). Normalizują przy refeedingu.
Białka + albumina	Markery odżywienia. Fosfataza alkaliczna — wskaźnik kostny (osteoporoza).
Amylaza (jeśli wymioty)	Podwyższona przy zapaleniu ślinianek z wymiotów. Obniżenie potasu i chlorków przy kompensacjach.

02 ☉ Hormony, EKG, DEXA — rozszerzona ocena

EKG · U WSZYSTKICH

Obowiązkowe przy BMI < 17, objawach krążeniowych lub kompensacjach przez wymioty. Bradykardia, wydłużenie QTc > 450 ms (ryzyko arytmii), niskie napięcie.

HORMONY TARCZYCY

TSH zwykle w normie lub obniżone (*sick euthyroid syndrome*). FT3 obniżony — adaptacja organizmu do głodu, *nie* choroba tarczycy.

GONADOTROPINY

LH, FSH obniżone (hipogonadyzm hipogonadotropowy). Estradiol u kobiet / testosteron u mężczyzn — obniżone. Wyjaśnia brak miesiączki.

DEXA · PO 6 MIES.

Densytometria po 6 mies. AN lub braku miesiączki > 6 mies. Ocena osteoporozy — typowe powikłanie AN, *częściowo* odwracalne.

03 ✎ Częstotliwość monitorowania — wg MEED 2022

STREFA MEED	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO KONKRETNIE
RED · krytyczna	Codziennie lub co 2–3 dni	Elektrolity (K, Na, Cl, P , Mg), kreatynina, EKG. Hospitalizacja.
AMBER · znacząca	Co 1–2 tygodnie	Panel podstawowy + elektrolity. Lekarz prowadzący kontroluje trend.
GREEN · stabilna	Co 4–12 tygodni	Panel pełny rzadziej, DEXA co 1–2 lata. Stabilność nie oznacza braku ryzyka.

Klucz: zlecenie panelu raz na początku, bez kontroli, jest *najczęstszym błędem* w opiece nad pacjentem z AN. Zmiany w trakcie leczenia są *bardziej diagnostyczne* niż pojedyncza wartość — szczególnie podczas refeedingu, gdy poziomy P, Mg, K mogą się szybko zmieniać. Każdy pacjent z AN potrzebuje lekarza prowadzącego (internista lub psychiatrę z doświadczeniem w ED) odpowiedzialnego za monitorowanie — psychoterapeuta *nie zastępuje* tej roli. Pacjenci wyglądający „stabilnie” mogą mieć zagrażające życiu zaburzenia (np. hipokaliemia < 3,0 daje ryzyko arytmii bez wyraźnych objawów). EKG *obowiązkowe* przy BMI < 17 lub objawach krążeniowych. DEXA po 6 mies. AN — bo osteoporoza wczesna jest niewidoczna w innych badaniach.

△ Wartości referencyjne są ustalane dla populacji ogólnej — w AN niektóre „nieprawidłowości” są adaptacyjne (niski FT3, niski LH/FSH). Wartości w „normie” mogą być klinicznie niepokojące (np. K 3,2 — formalnie w normie, w AN sygnał ostrzegawczy). Wymaga interpretacji lekarza z doświadczeniem ED.